# 방광염 — 항생제 전에 소변검사, 그리고 끝까지

방광염은 방광에 세균이 들어와 생기는 흔한 감염으로, 소변 볼 때 따갑거나 갑자기 자주 마려운 증상이 대표적입니다. 검사와 복용 순서를 지키는 것이 정확한 진단과 재발 예방의 핵심입니다.

## 치료의 원칙 3가지



| 원칙 | 실천 방법 |
|---|---|
| 1 | **항생제를 먹기 전에 소변검사를 받으세요** — 약을 먹은 뒤에는 검사가 부정확할 수 있습니다. 필요하면 배양검사도 함께 하고, 결과가 나오면 더 잘 듣는 약으로 바꿀 수 있습니다. |
| 2 | **처방받은 기간(예: 5일) 끝까지 드세요** — 증상이 좋아져도 임의로 중단하지 마세요. 약마다 정해진 기간이 다르므로, 처방받은 대로 끝까지 복용하는 것이 핵심입니다. |
| 3 | **물을 많이 마시고 소변을 참지 마세요** — 수분을 충분히 섭취하고, 소변이 마려울 때 습관적으로 오래 참지 않는 것이 회복과 재발 예방에 도움이 됩니다. |

## 흔한 오해 바로잡기

| 흔한 오해 | 바로 알기 |
|---|---|
| **"소변이 잦으면 콩팥이 나쁜 것"** | 아닙니다. 빈뇨는 대개 방광의 문제이고, 콩팥까지 번진 경우는 열·옆구리 통증으로 나타납니다. |
| **"주사 항생제 한 방이면 된다"** | 주사 항생제는 상황에 따라 함께 쓸 수 있지만, 방광염 치료의 기본은 처방받은 기간 동안 먹는 항생제를 다 복용하는 것입니다. |

## 이런 경우는 구분이 필요합니다

### 신우신염 의심 · 바로 오세요

- **옆구리 통증, 열·오한**이 있으면 신우신염일 수 있습니다. 바로 오세요.
- **메스꺼움·구토**가 함께 있는 경우
- **방광염 약을 먹는데도** 증상이 나아지지 않거나 오히려 나빠지는 경우

몹시 아프거나 상태가 빠르게 나빠지는 경우 — 열이 높고 구토로 약을 못 드시거나 크게 처지면 응급실로

### 오래된 빈뇨는 다를 수 있음

- **오래된 빈뇨는 염증이 아니라 과민성 방광**일 수 있습니다.
- 새로 갑자기 생긴 배뇨통·빈뇨는 방광염 쪽에 가깝습니다.
- 오래 지속된 빈뇨만으로는 급성 방광염으로 단정하지 않습니다.
- 구분이 애매하면 진료 시 함께 확인하세요.

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 국내 요로감염 항생제 사용지침 2018 · IDSA/ESCMID 요로감염 치료지침 2010 · EAU 요로감염 지침 2026 · AUA/SUFU 과민성 방광 지침 2024

*본 자료는 일반적인 성인 여성의 단순 방광염 안내입니다. 임신, 재발성 감염, 남성의 요로감염, 신우신염 의심 상황은 검사와 치료 방침이 달라질 수 있으니 진료 시 확인하세요.*

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/screening/cystitis-uti/